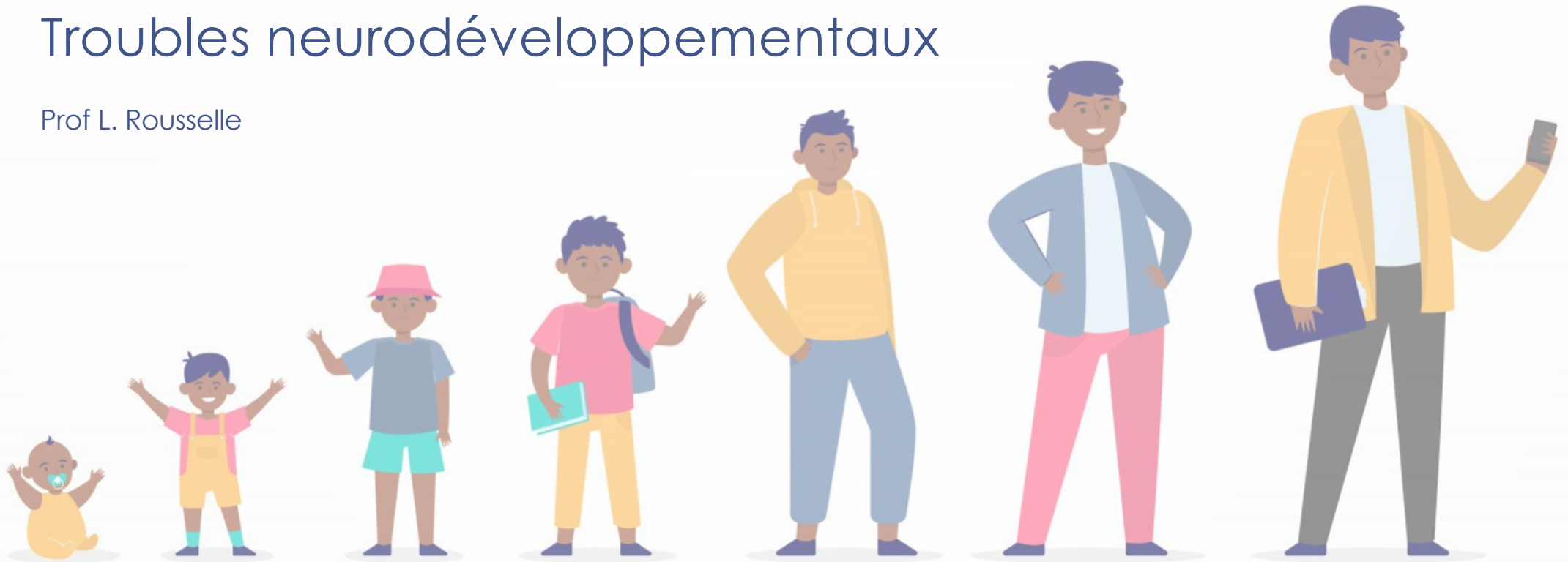




Troubles neurodéveloppementaux

Prof L. Rousselle





Objectifs du cours

- Que sont les TND?
- La question de la normalité
- La question de la limite
- Différents tableaux cliniques
 - Déficience intellectuelle
 - Troubles de la communication
 - TSA
 - TDAH
 - Troubles spécifiques des apprentissages
 - Troubles moteurs



Approche Descriptive : le DSM-5

APA (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th edition

- Système de nomenclature des troubles mentaux s'appuyant sur le modèle médical de type catégoriel
- Largement utilisé en clinique mais aussi critiqué pour l'absence de fondement théorique
- But :
 - lister des critères diagnostiques non ambigus des troubles mentaux
 - constituer un langage commun utilisé par tous les cliniciens/chercheurs
 - *American Psychiatric Association : DSM-5 (2013)*

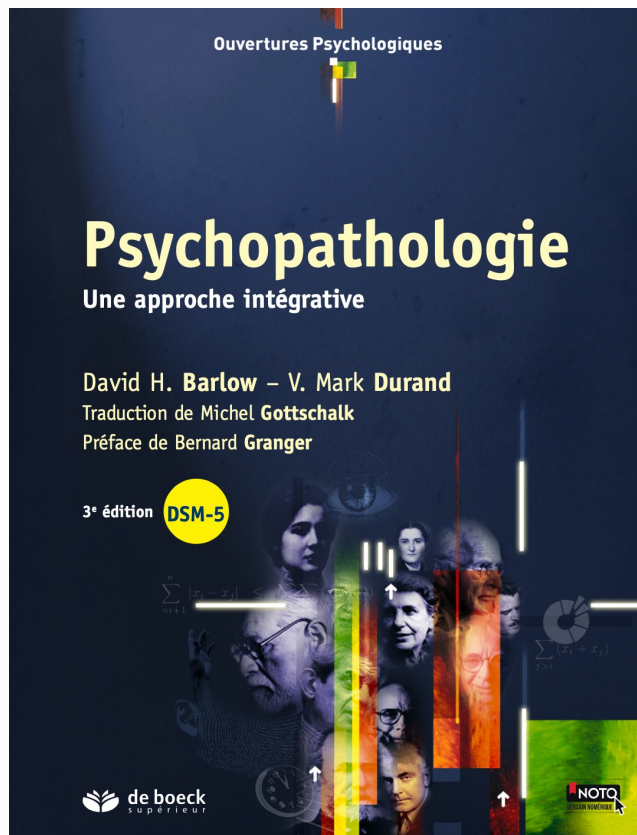


Approche Descriptive : le DSM-5

APA (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th edition

- Distingue notamment :
 - Troubles neurodéveloppementaux
 - Troubles du spectre schizophrénique
 - Troubles bipolaires
 - Troubles dépressifs
 - Troubles anxieux
 - Troubles Obsessionnels Compulsif
 - Troubles liés au stress/traumatisme (PTSD)
 - Troubles dissociatifs
 - Troubles des conduites alimentaires
 - Troubles de la personnalité
 - Etc.

Troubles neurodéveloppementaux



SOMMAIRE

Vue d'ensemble des troubles neurodéveloppementaux

Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas ?

Trouble déficit de l'attention / hyperactivité

Trouble spécifique des apprentissages

Trouble du spectre de l'autisme

Traitement du trouble du spectre de l'autisme

Handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel)

Causes

Prévention des troubles neurodéveloppementaux



Troubles neurodéveloppementaux?

- Troubles d'origine neurobiologique
- Se manifestent durant l'enfance
- Persistent souvent à l'adolescence et à l'âge adulte
- Perturbation de la trajectoire développementale
- Impact fonctionnel/retentissement clinique significatif (famille, école, relations sociales)
- Grande hétérogénéité des profils et recouvrement
- Relèvent de la psychopathologie développementale = étude de la façon dont les troubles se développent et évoluent

Une perspective développementale

- L'enfant développe une compétence avant d'acquérir la suivante
- Chaque compétence acquise forme la base pour acquérir la suivante
- Effet cascade : Toute perturbation du développement d'une aptitude précoce perturbera le développement des aptitudes qui la suivent et dont elle est un prérequis.



- Ces effets donnent du sens aux interventions précoces

L'effet cascade : comment la motricité de votre bébé nourrit son intelligence

Le développement moteur est le moteur essentiel pour ses apprentissages perceptifs et cognitifs.

Le mouvement : le moteur de l'apprentissage

Le développement moteur déclenche une cascade d'apprentissages.

Chaque nouveau mouvement ouvre des portes sur les plans perceptif, cognitif et même social.

L'expérience motrice est le principal moteur du changement.

L'exploration par le mouvement est plus déterminante pour l'apprentissage que l'âge seul.



En bougeant, le bébé devient un petit scientifique. Il génère des informations sur son corps, les objets et les distances, apprenant par l'action.

Une nouvelle étape, une nouvelle vision du monde

La position assise stable libère les mains. Le bébé peut alors explorer les objets plus finement et comprendre leur nature tridimensionnelle.

Le quatre-pattes permet d'explorer l'espace. Il découvre les distances, les obstacles et voit les choses sous de nouveaux angles.

La marche offre une perspective plus large. Elle libère les mains pour transporter des objets et élargit son horizon d'exploration.

Des bénéfices à long terme

Les avancées motrices précoces sont liées à de meilleures performances cognitives plus tard. Un enfant qui a bien exploré avec son corps a de meilleures bases pour les apprentissages futurs.

La motricité fine est associée à de meilleurs résultats scolaires. Notamment en mathématiques et en lecture, qui reposent sur des compétences développées tôt.

Comment favoriser cet "effet cascade" ?



Privilégiez le jeu libre au sol. Le "temps sur le ventre" (tummy time) est essentiel pour renforcer les muscles du haut du corps.



Créez un environnement sécurisé et stimulant. Un espace qui invite à l'exploration encourage le bébé à bouger et à découvrir par lui-même.



Laissez votre bébé faire ses propres expériences. Apprendre en faisant est la voie la plus rapide pour comprendre son corps et le monde.



La question de la normalité

- Norme = le juste milieu, la moyenne, ce qui sert généralement de référence
- Selon les définitions, concept potentiellement dangereux car relatif et subjectif
- Varie selon
 - les époques
 - les cultures
 - les sociétés
 - et même les circonstances...



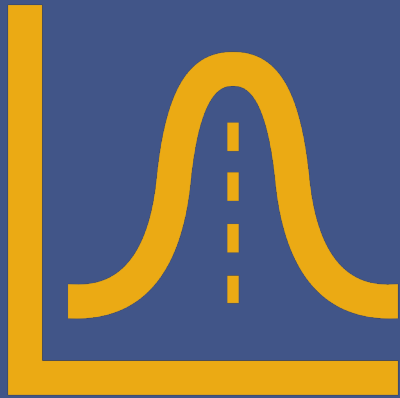
Plusieurs conceptions de la normalité

Normalité statistique

Normalité sociale

Normalité fonctionnelle

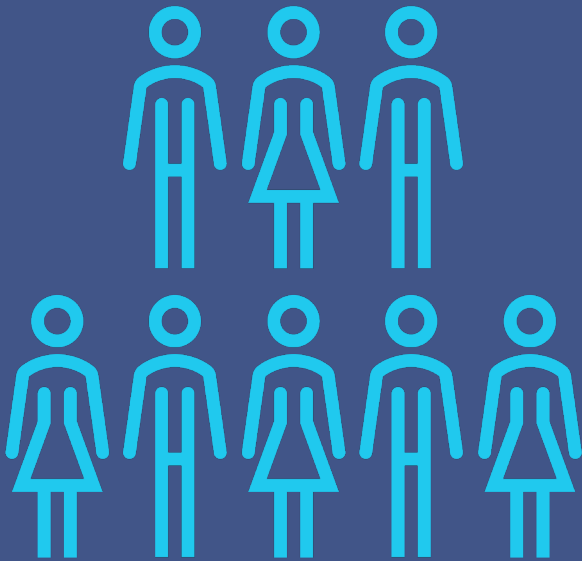
Normalité statistique



- La norme définie par la **fréquence** : norme = Comportements partagés par le + grand nombre
 - individus dits normaux = les individus qui se comportent comme la majorité du groupe de référence

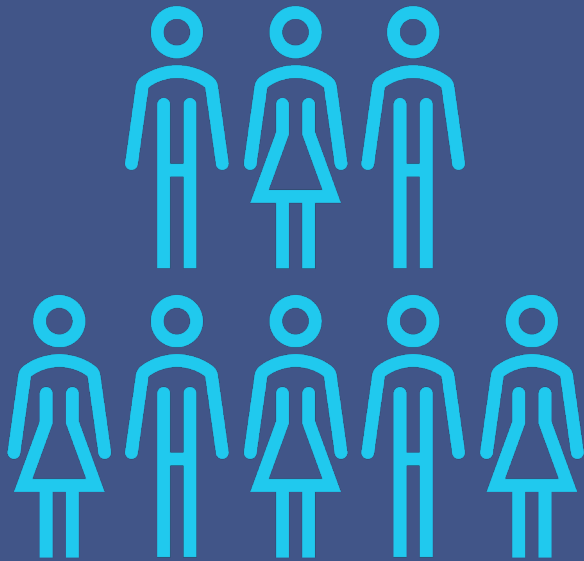
Ex : le QI : $M=100$, $SD = 15$
 - Peu adaptée à l'étude des phénomènes psychiques/des comportements

Normalité sociale



- La norme définie par les **règles** éthiques, sociales et culturelles **d'une société donnée**
- Equilibre psychologique = conformisme social ou culturel à l'idéal collectif
- Conception insuffisante :
 - Conformité sociale = sain vs non-conformité = déviant ...
Dichotomie abusive
 - Norme sociale = variable selon les époques et selon les cultures
- Importance d'être conscient de son propre cadre référentiel, social et culturel
- Permet de désactiver certains préjugés % à la différence

Normalité sociale



➡ DOUBLE IMPLICATION

En tant qu'observateur :

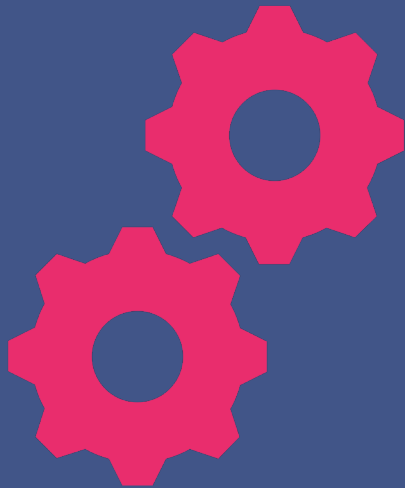
- Importance d'être **conscient de son propre cadre référentiel**, social et culturel > travail à faire sur nos préjugés % à ce qui est différents de nous
- Importance **d'interpréter** les comportements des individus dans le cadre culturel de la personne, **dans le cadre de la norme sociale du groupe d'appartenance**



Ethnopsychiatrie : discipline qui étudie :

- comment une culture définit ce qui est « normal » ou « pathologique »
- comment les symptômes psychiques s'expriment différemment selon les contextes culturels
- comment adapter les soins psychologiques et psychiatriques à ces contextes

Normalité fonctionnelle

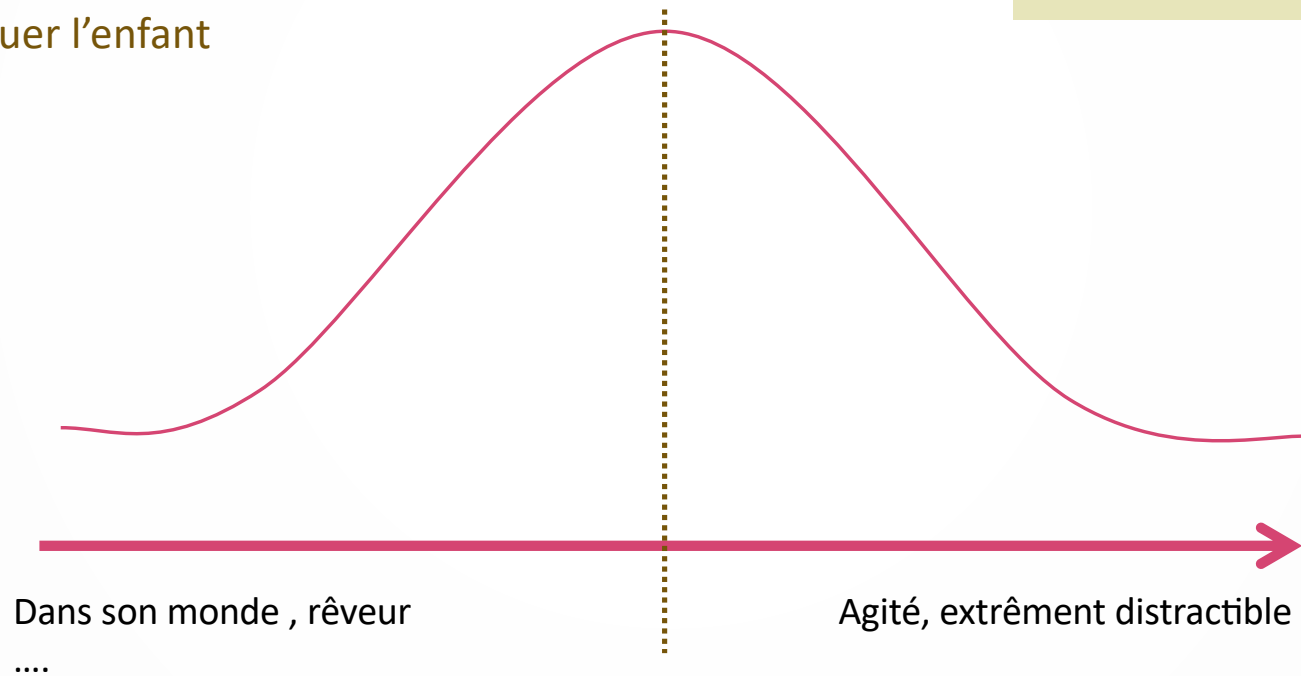


- La norme définie en fct° de **l'épanouissement** psychologique et le **fonctionnement optimal** de la personne dans ses différents milieux de vie
- référence aux caractéristiques propres de la personne
- référence aussi aux capacités d'adaptation de l'individu
Individu sain = capacités de changement et d'adaptation à des situations nvelles
- **Continuum normal-pathologique** entre les différents modes de fonctionnement psychique
- Limite?
- Notion d'atteinte au fonctionnement social et familial de l'individu

Question de la limite

- Evaluer = situer l'enfant

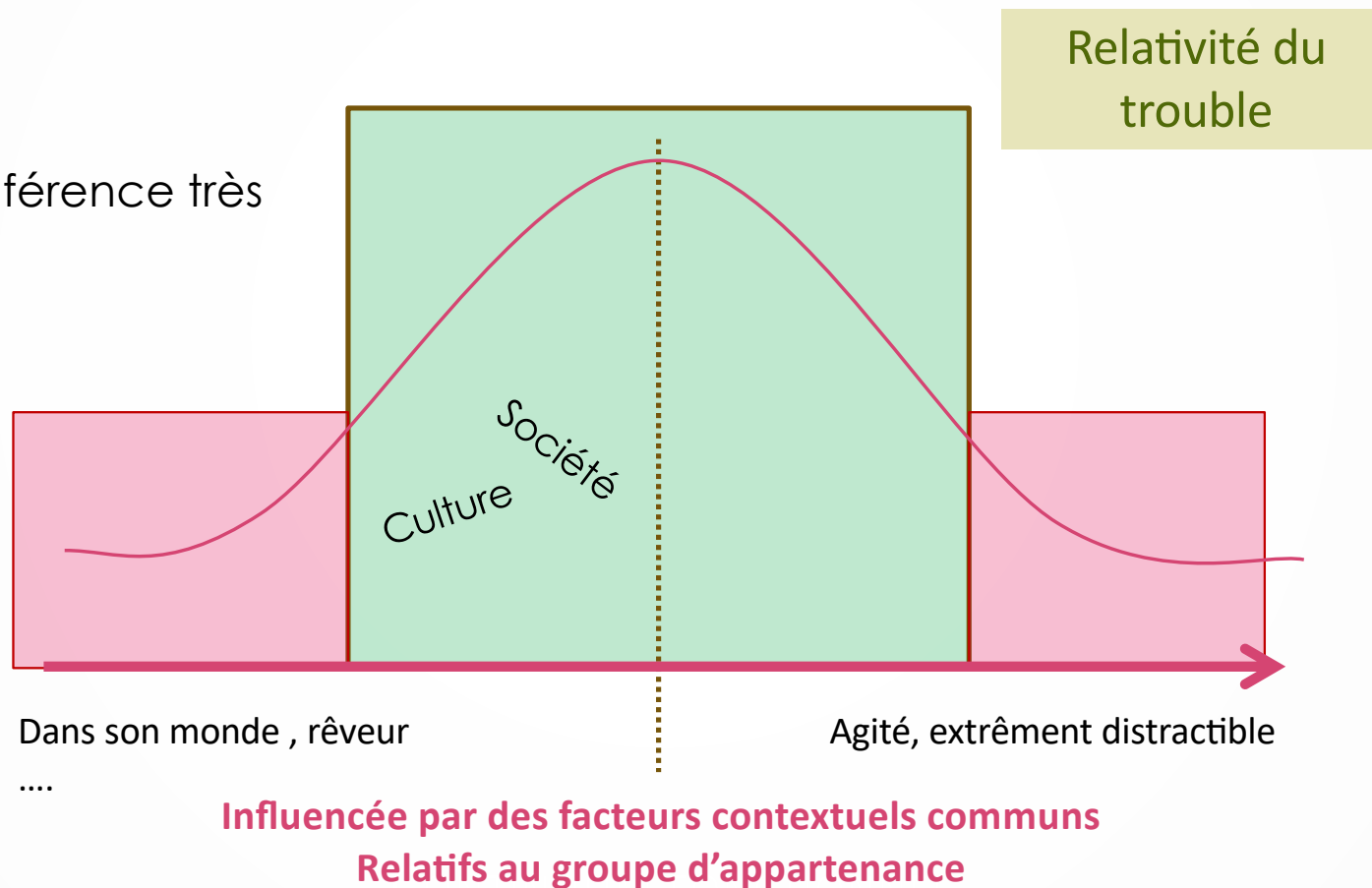
Relativité du
trouble



Question de la limite

La norme...

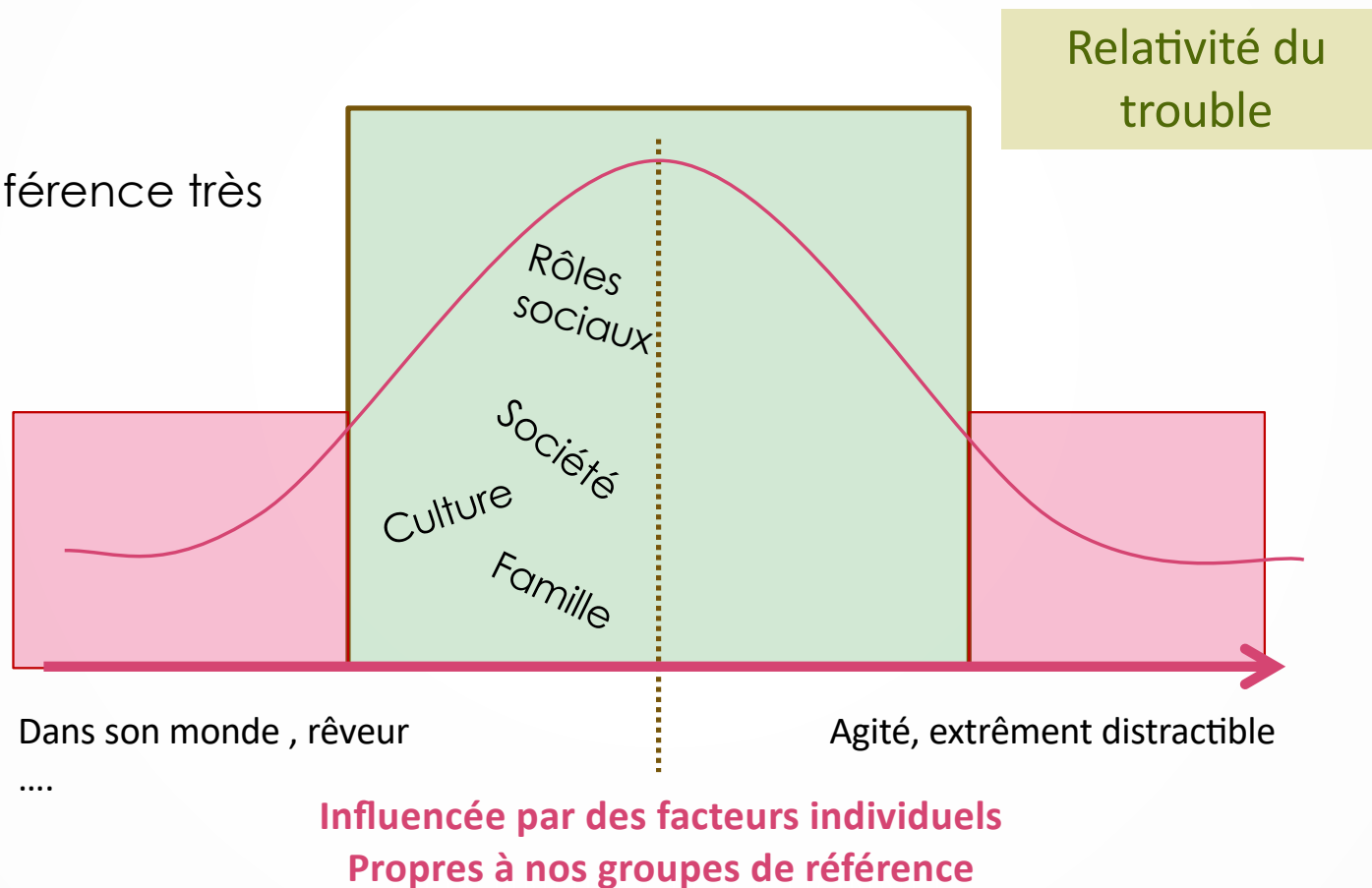
Un point de référence très
subjectif



Question de la limite

La norme...

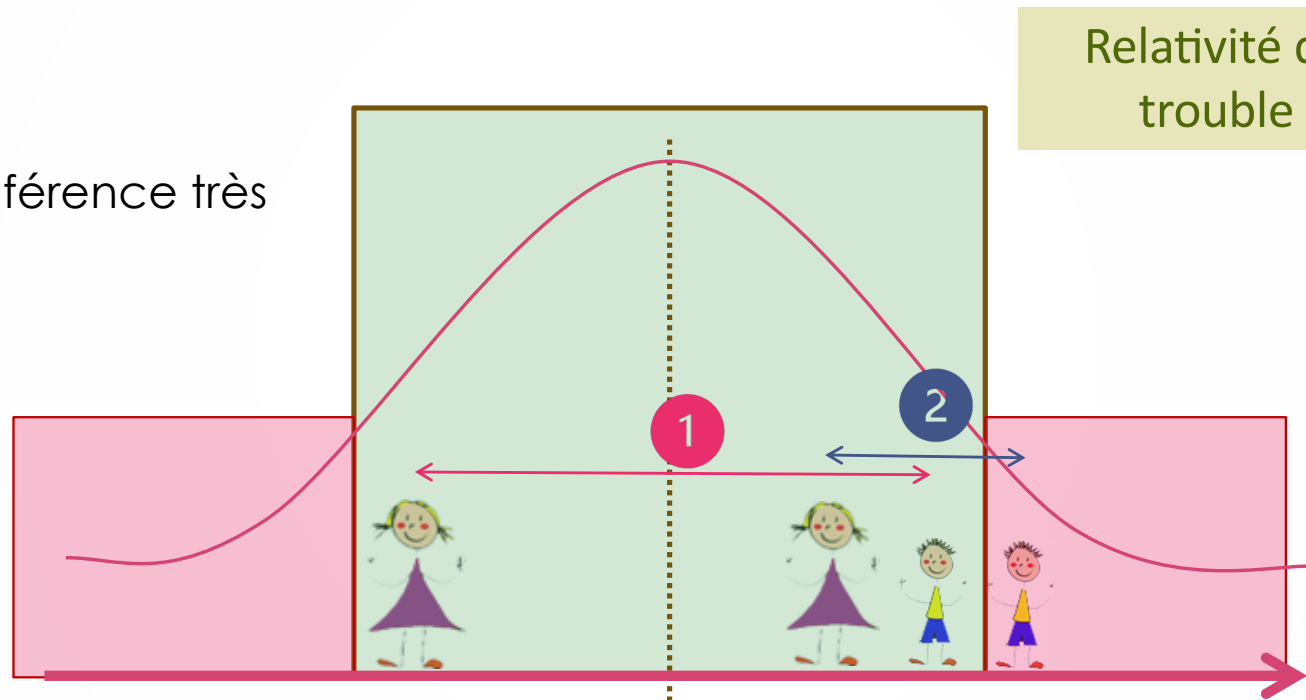
Un point de référence très
subjectif



Question de la limite

La norme...

Un point de référence très
subjectif



Dans son monde , rêveur

....

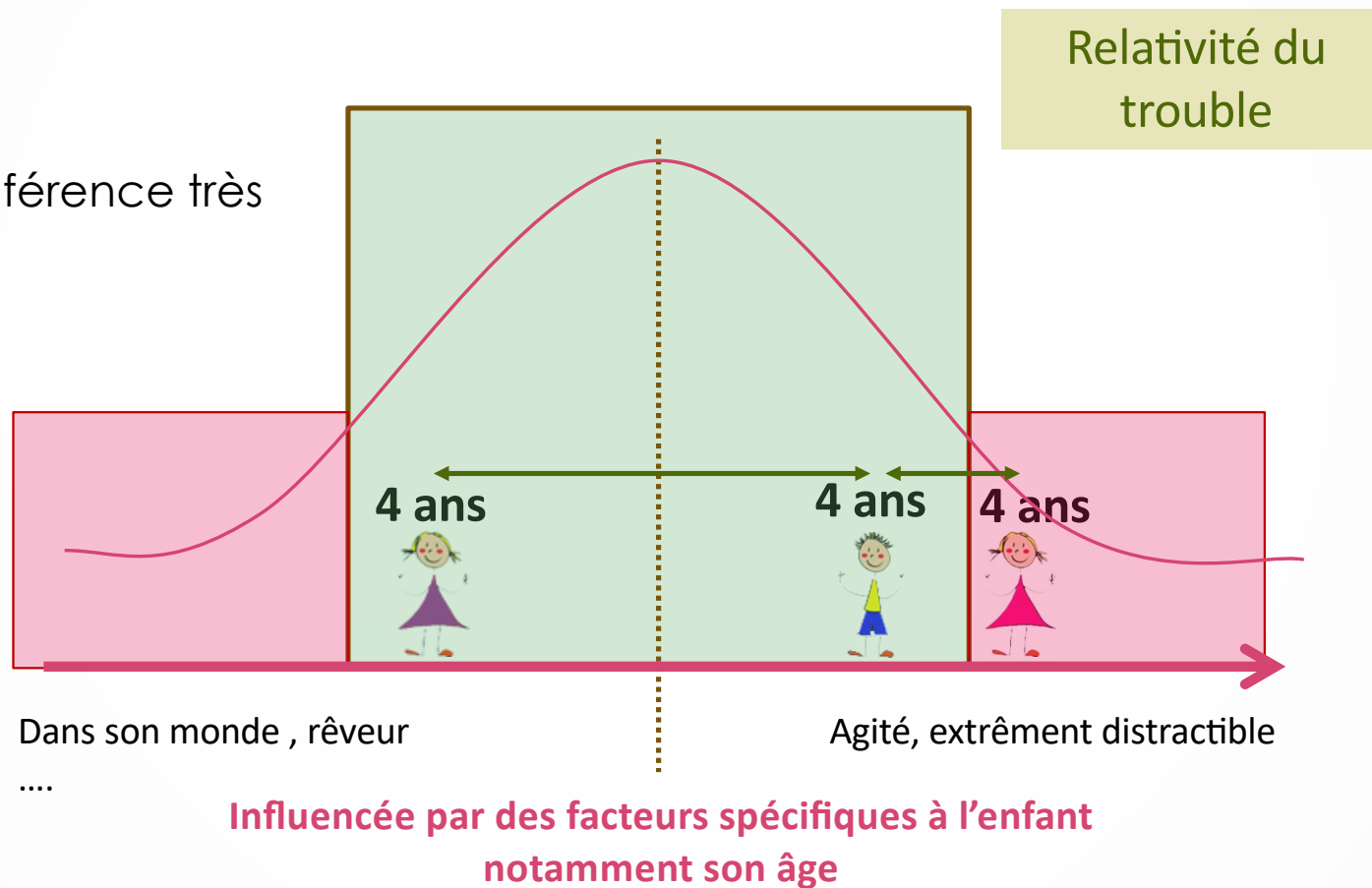
Agité, extrêmement distractible

**Influencée par des facteurs individuels
propres à nos groupes de référence,
notamment nos points de repère intra-familiaux**

Question de la limite

La norme...

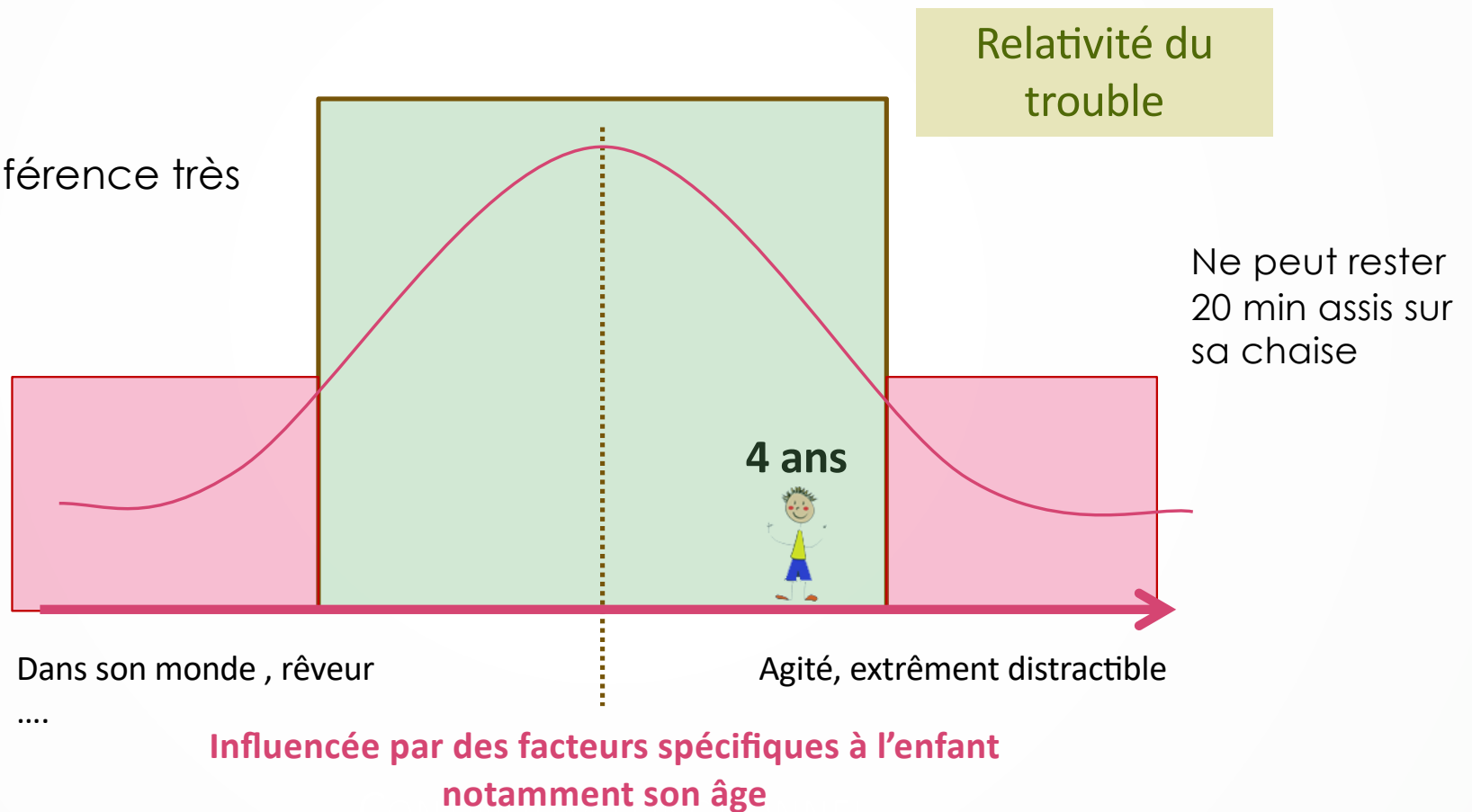
Un point de référence très
subjectif



Question de la limite

La norme...

Un point de référence très
subjectif

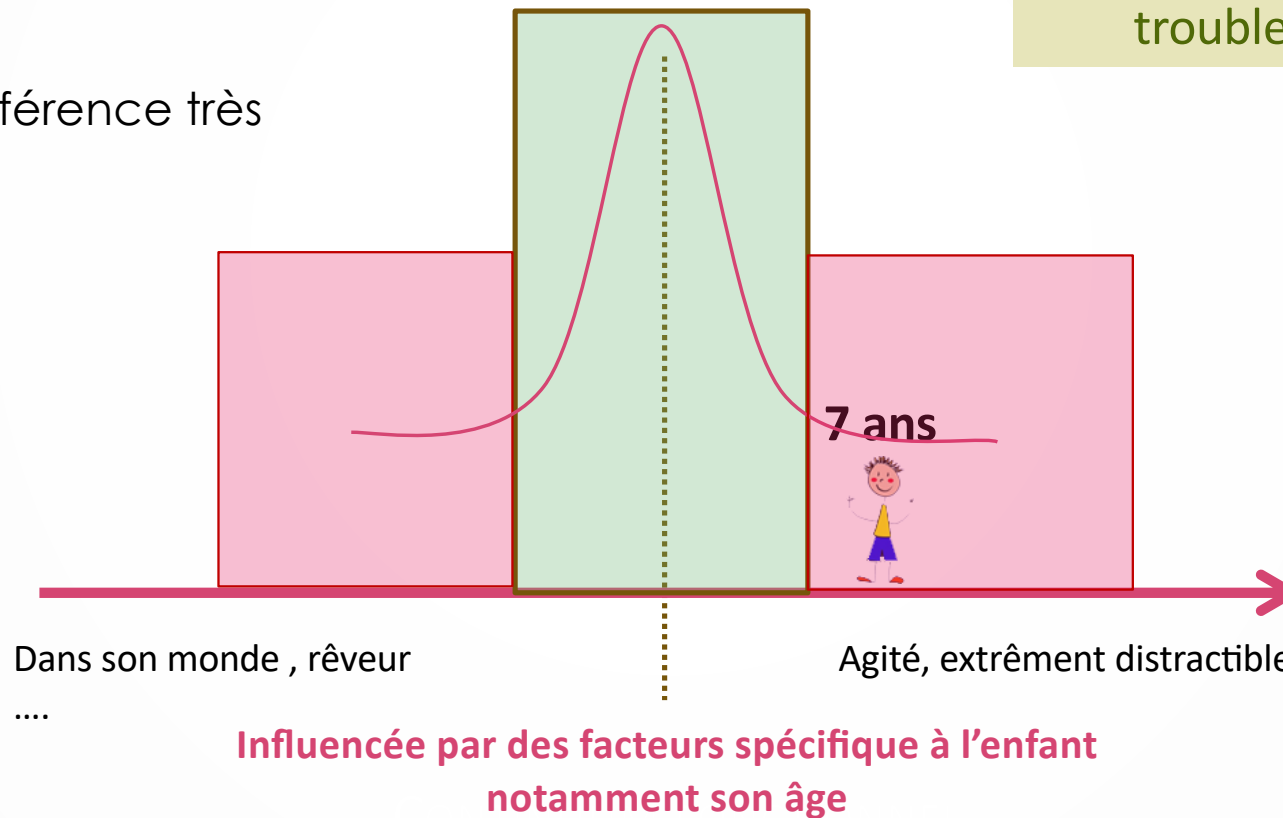


Question de la limite

La norme...

Un point de référence très
subjectif

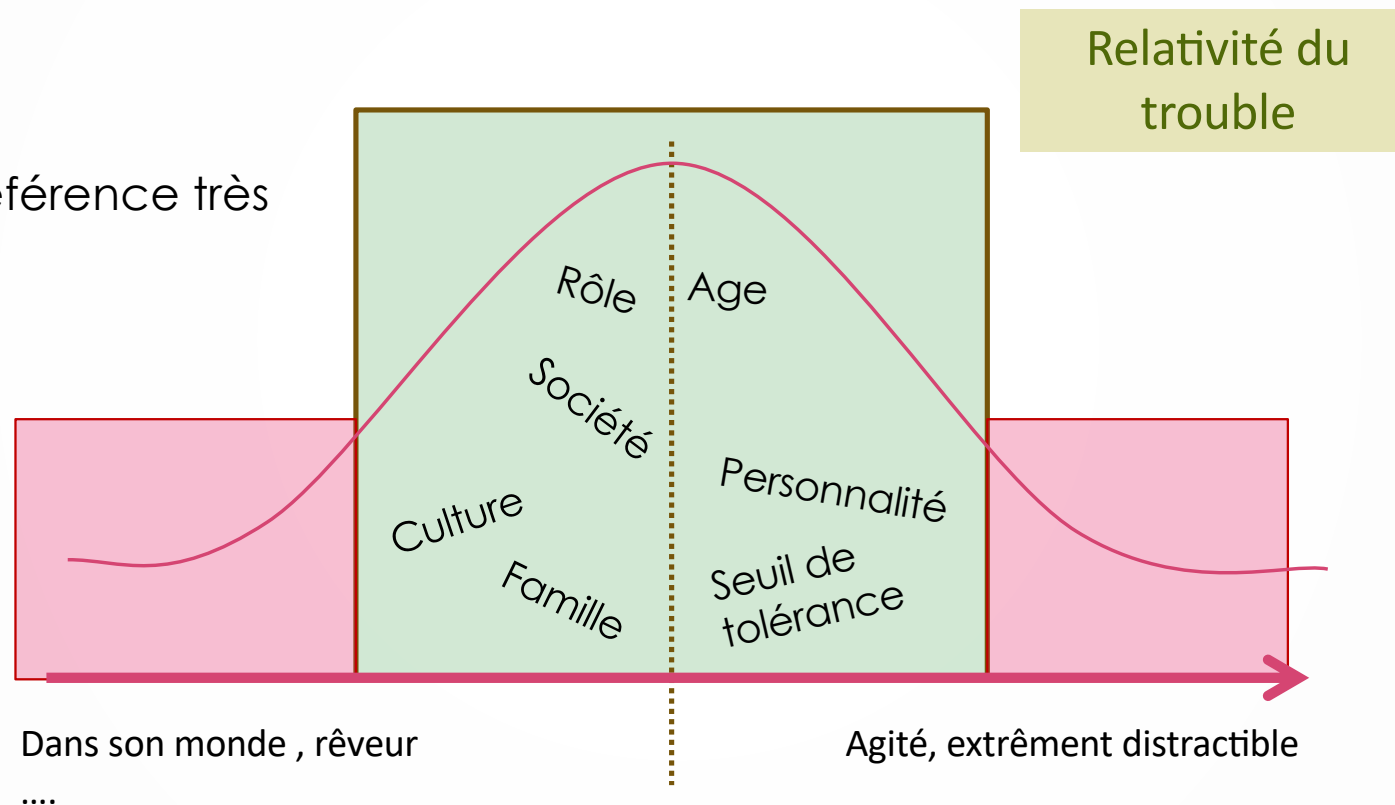
Relativité du
trouble



Question de la limite

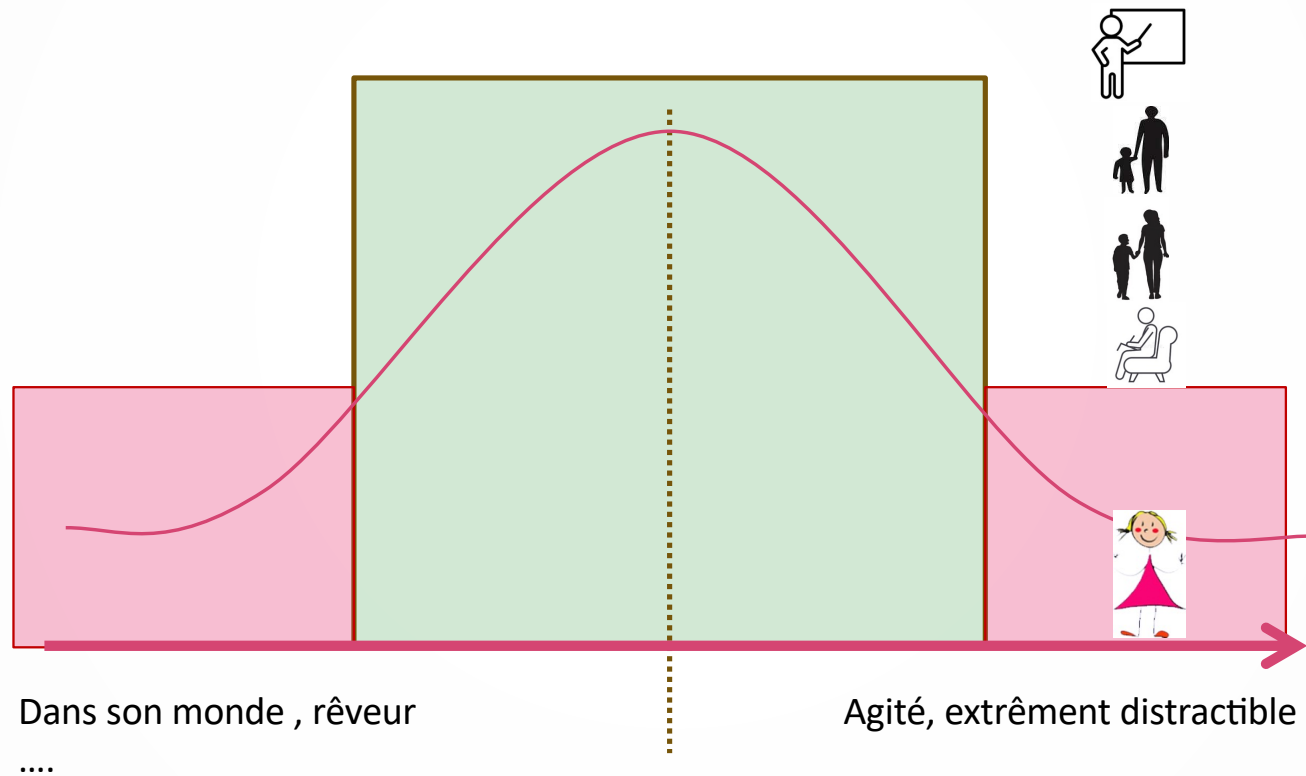
La norme...

Un point de référence très
subjectif



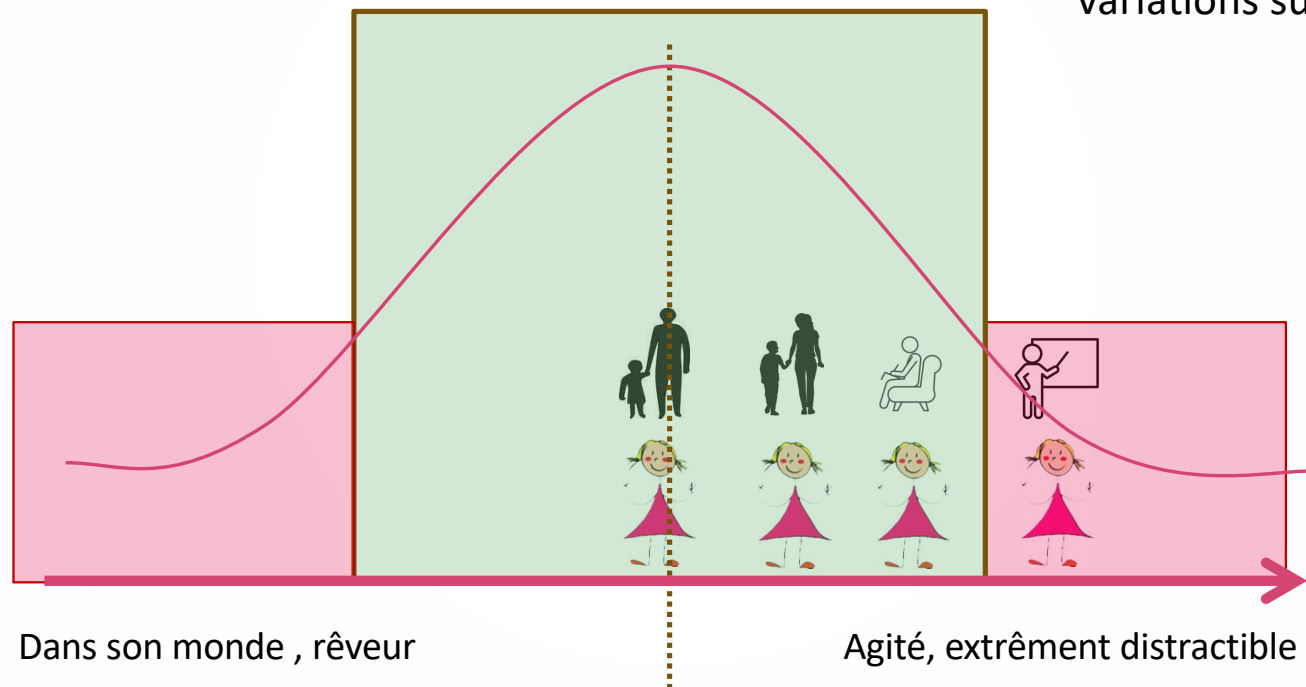
**Influencée par des facteurs spécifique à
l'observateur (facteurs personnels)**

La concordance... un signe de fiabilité



Disconcordances fréquentes

Les variations dans la norme de référence induisent des variations suivant l'observateur



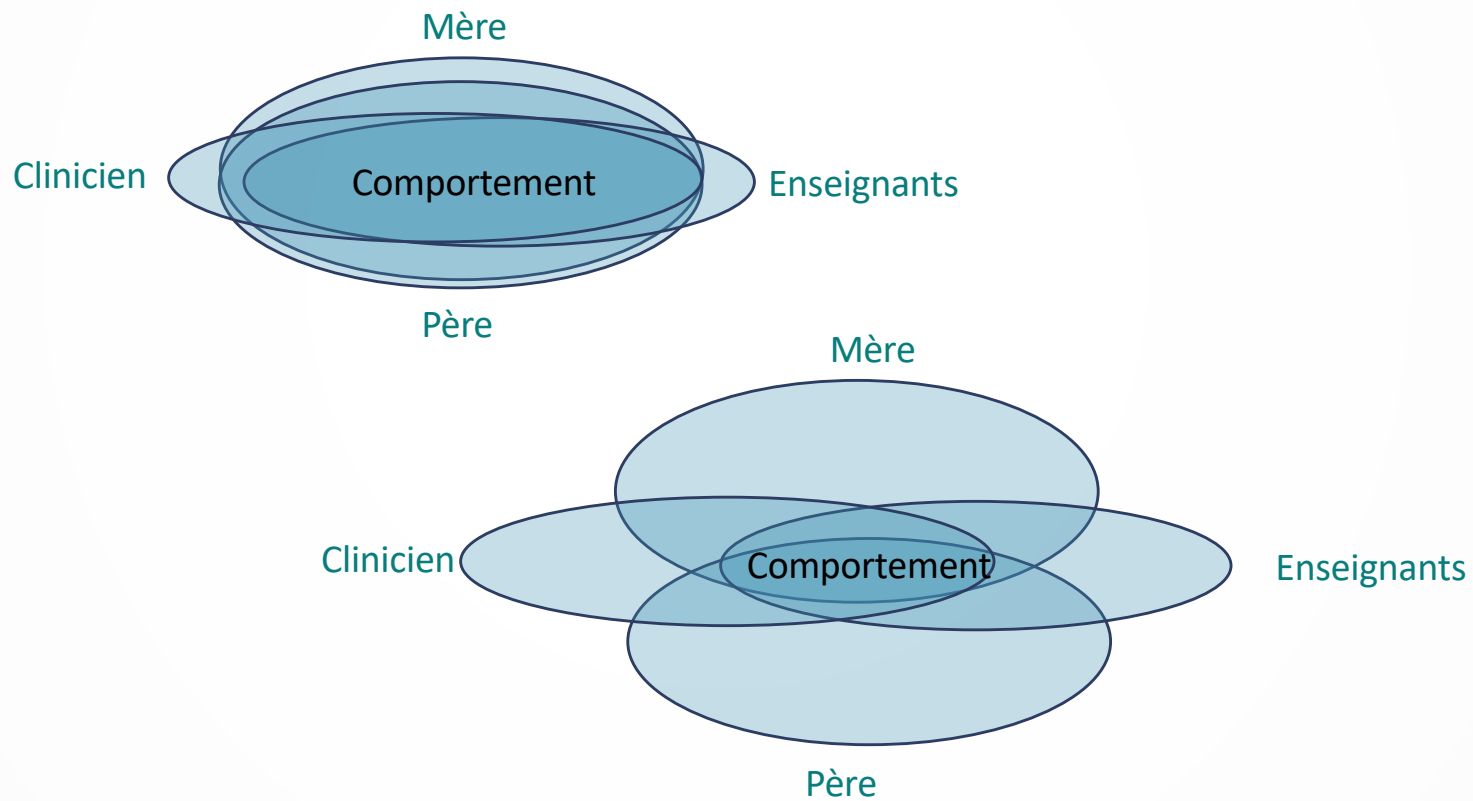
Dans son monde , rêveur

Agité, extrêmement distractible

....

=> Dialogue parfois difficile, sentiment d'incompréhension

Variations contextuelles du comportement

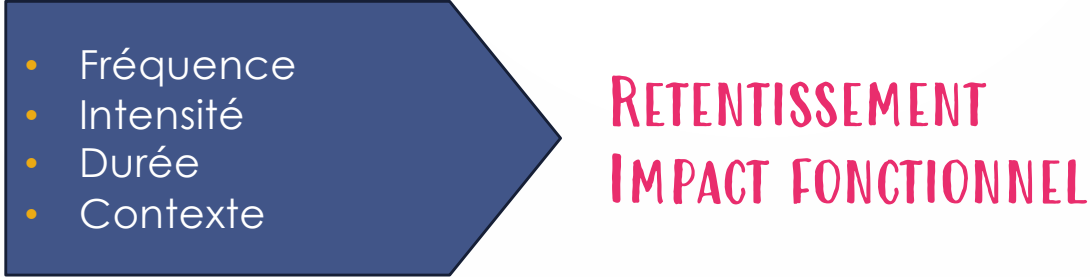




Conclusion

La frontière entre le normal et le pathologique est une limite très relative :

- Tous les comportements atypiques ne sont pas pathologiques
- Importance d'avoir des repères développementaux pour aborder la pathologie
- Importance de questionner son propre cadre de référence
- Importance de questionner le cadre de référence de l'observateur
- Evaluer les comportements sous l'angle de la normalité fonctionnelle

- 
- A diagram consisting of a dark blue arrow pointing to the right. Inside the arrow, on the left side, is a list of four factors: Fréquence, Intensité, Durée, and Contexte. To the right of the arrow, the words 'RETENTISSEMENT' and 'IMPACT FONCTIONNEL' are written in pink, stacked vertically.
- Fréquence
 - Intensité
 - Durée
 - Contexte

RETENTISSEMENT
IMPACT FONCTIONNEL

Exercices!



wooclap

Event code

JZANJM



Catégorisez

Regroupez les enfants selon leur domaine de difficultés

Pour chaque groupe : identifiez

- les caractéristiques communes
- les différences éventuelles

Nommez les domaines de difficulté



Important

Il n'y a pas une seule bonne réponse

Certaines vignettes peuvent appartenir à plusieurs groupes

Justifiez vos choix



10 vignettes cliniques.



Par petit groupe de 2-3 étudiants



1

Enfant de 7 ans

Se lève souvent en classe, interrompt les autres, oublie ses affaires
A du mal à terminer les exercices à l'école et semble facilement distrait
Les enseignants décrivent un enfant "toujours en mouvement"

4

Enfant de 6 ans

Passé de longues périodes à aligner des objets
il se met en colère si il y a des imprévus
S'intéresse de manière très intense à un thème spécifique

7

Enfant de 8 ans

Difficultés importantes pour écrire lisiblement
Difficulté dans les jeux de balle et bricolage
Maladroit dans les tâches du quotidien, il se cogne souvent et reverse les objets

2

Enfant de 4 ans

Ne pointe pas pour montrer des objets
Ne parle pas
Ne répond pas à son prénom ni aux demandes qui lui sont faites
Il joue le plus souvent tout seul et ne va pas vers les autres

5

Enfant de 9 ans

Présente des mouvements brusques de la tête et cligne fréquemment des yeux
Il renifle en permanence
Il est isolé et a peu d'amis

8

Enfant de 9 ans

Difficultés marquées en lecture malgré un enseignement adapté
Confond certaines lettres et lit très lentement
Comprend mieux à l'oral qu'à l'écrit

3

Enfant de 10 ans

Difficultés en mathématiques : ne comprend pas les quantités
Se trompe dans les calculs simples
semble souvent en retrait dans les interactions et participe peu aux jeux collectifs
Pas à l'aide dans l'interaction

6

Enfant de 8 ans

Les apprentissages sont difficiles (lire, écrire et calculer)
A besoin d'aide pour les activités du quotidien, car il est lent et maladroit
Son vocabulaire est limité
il est peu intégré

9

Enfant de 5 ans

Comprend les consignes simples mais parle peu
Ses phrases sont courtes et mal structurées
Se fait difficilement comprendre par les autres enfants



Domaines dégagés ?



Plusieurs tableaux cliniques

APA (2013) DSM-5

Intellectual Disability

- Léger
- Modéré
- Sévère
- Profond

Deficience intellectuelle



Communication Disorders

- Trouble du langage
- Trouble des sons de la parole (Phonologique)
- Trouble de la fluidité verbale (bégaiement)
- Trouble de la communication sociale (pragmatique)

Troubles de la communication



Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

- Inattention prédominante
- Hyperactivité-impulsivité prédominante
- mixte

Trouble déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH)



Autism spectrum disorder

- Différents niveaux de sévérité selon le soutien requis
- Avec ou sans :
 - déficience intellectuelle
 - trouble du langage

Trouble du spectre de l'autisme



Motor Disorders

- Syndrome de Gilles de la Tourette
- Trouble de tics moteurs ou vocaux persistants
- Trouble de tics provisoire

Troubles moteurs



Specific Learning Disorder

- Difficultés persistantes dans :
 - lecture (dyslexie)
 - Expression écrite et orthographe (dysorthographe)
 - mathématiques

Troubles spécifiques des apprentissages



Points communs

- Série de symptômes spécifiques
- Présence durant la période développementale
 - > précision spécifique à chaque trouble
- Altération cliniquement significative du fonctionnement (social, scolaire ou professionnel)
 - > impact fonctionnel
- Diagnostic différentiel : Elimination des autres causes possibles qui rendraient mieux compte des symptômes
 - > spécifique à chaque trouble

Déficiência intellectuelle



- Abandon de la terminologie «retard mental» pour «déficiência intellectuelle» (ou trouble du développement intellectuel)
- Trouble développemental qui se manifeste par un fonctionnement et un niveau intellectuel significativement inférieur à la moyenne des enfants de même âge
- Début durant la période développementale (enfance et adolescence)
- 2 Pôles de déficits au niveau
 - Des fonctions intellectuelles
 - Du fonctionnement adaptatif
- **impact fonctionnel** : Difficultés à accomplir des tâches banales de la vie quotidienne à un niveau reflétant la sévérité de leurs déficiences cognitives ainsi que le type et l'importance d'assistance dont ils ont besoin.
- Prévalence estimée : environ 1%

APA (2013) DSM-5

2 Pôles de symptômes

Déficit des fonctions intellectuelles

- le raisonnement
- la résolution de problèmes
- la planification
- la pensée abstraite
- le jugement
- les apprentissages scolaires
- l'apprentissage par l'expérience

Déficit du fonctionnement adaptatif

- Altération du fonctionnement dans une ou plusieurs activités de la vie quotidienne limitant l'autonomie personnelle la responsabilité sociale (participation sociale)
- dans différents environnements, tels que le domicile, l'école, le travail et la communauté.
- Besoin de soutien pour fonctionner dans ces différents environnements

Fonctionnement adaptatif?

- 3 domaines :
 - Le domaine conceptuel : langage oral, écrit, math, raisonnement connaissance et mémoire.
 - Le domaine social : empathie, jugement social, communications interpersonnelles, capacités à établir et à conserver des liens d'amitié, et autres capacités similaires
 - Le domaine pratique : autonomie dans les domaines du soin personnel, du travail, gestion de l'argent, loisir, organisation des tâches scolaires et professionnelles, sécurité
- Ces domaines déterminent comment un individu parvient à faire face aux tâches quotidiennes dans ses différents environnement de vie



Poser le diagnostic

- Nécessité de baser le diagnostic sur :
 - Une évaluation standardisée du fonctionnement intellectuel (domaine conceptuel)
 - Un examen clinique visant à apprécier les 3 domaines de fonctionnement adaptatif
- Différent niveau de sévérité :
 - Léger, modéré, sévère ou profond
 - Déterminé en regard du **fonctionnement adaptatif** (et non plus sur base du QI seul) et donc de l'intensité des besoins de soutien dans la vie quotidienne
- Les DI légères peuvent passer longtemps inaperçues que les DI plus sévères

TDAH



- Trouble développemental qui se manifeste par la présence de symptômes d'inattention et /ou d'hyperactivité-impulsivité
 - Certains symptômes présents avant l'âge de 12 ans
 - Gêne fonctionnelle liée aux symptômes **dans au moins 2 environnements**
 - **impact fonctionnel** : Altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel
 - **Diagnostic différentiel** : Elimination des autres causes possibles qui rendraient mieux compte des symptômes
 - Schizophrénie ou autre troubles psychotiques
 - Autres troubles mentaux (troubles dépressif, bipolaire, anxieux, dissociatif, de la personnalité, prise de substance ou état de manque)
- Rem : plus d'exclusion des TSA dans le diagnostic d'ADHD
- Prévalence estimée : environ 5% des enfants et 2,5 % des adultes

Symptômes d'inattention

INATTENTION

- Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails, fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ...
- A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux
- Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement
- Souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs, ses tâches domestiques (ceci n'étant pas dû à un comportement d'opposition ou une incompréhension des consignes)
- A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités
- Souvent évite, a en aversion ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu (travail scolaire, devoir ...)
- Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou ses activités
- Souvent, se laisse facilement distraire par des stimuli externes
- A des oublis fréquents dans la vie quotidienne

Uh oh. Teacher called on me. Wasn't listening.



Symptômes d'hyperactivité-impulsivité

HYPERACTIVITÉ

- Remue souvent les pieds et les mains, se tortille sur son siège
- Se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis
- Souvent court ou grimpe partout dans des situations où cela est inapproprié (ado : sentiment d'impatience motrice)
- A souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir
- Est souvent « sur la brèche » ou agit souvent comme s'il était monté sur des ressorts
- Parle souvent trop



IMPULSIVITÉ

- Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée
- A souvent du mal à attendre son tour
- Interrompt souvent les autres ou impose sa présence (dans les jeux ou les conversations)



Différents types de TDAH suivant le DSM-5

- Trouble du Déficit de l'attention/hyperactivité, *type mixte*
 - ≥ 6 symptômes d'inattention pendant > 6 mois
 - ≥ 6 symptômes d'hyperactivité ou impulsivité pendant > 6 mois
- TDAH, *type inattention prédominante (ou ADD)*
 - ≥ 6 symptômes d'inattention pendant > 6 mois
- TDAH, *type hyperactivité prédominante*
 - ≥ 6 symptômes d'hyperactivité ou impulsivité pendant > 6 mois
- Note : A partir de 17 ans et chez l'adulte, 5 symptômes dans chacune de ces catégories suffisent

Troubles de la communication



- Les troubles de la communication incluent des déficits de la parole, du langage et de la communication.



Parole, Langage & Communication



La parole: production des sons



- Articulation
- Fluidité
- Voix



Le langage

- Inclut la forme, la fonction et l'utilisation d'un système conventionnel de symboles (mots parlés, langue des signes, mots écrits, images), organisé selon des règles pour communiquer.

La communication

- Englobe tout comportement verbal ou non verbal (intentionnel ou non) qui influence le comportement, les idées ou les attitudes d'autrui. ▶



Troubles de la communication



- Les troubles de la communication incluent des déficits de la parole, du langage et de la communication.
- Présent durant la période développementale précoce mais peuvent ne se manifester pleinement plus tard que lorsque les exigences en termes de communication sociales augmentent
- Inclus
 - le trouble développemental du langage
 - Le trouble des sons de la parole
 - le trouble de la fluidité verbale (Bégaiement)
 - Le trouble de la communication sociale (pragmatique)
 - Troubles de la communication non spécifiés
- **Impact fonctionnel** sur la communication, la participation sociale, la réussite scolaire/professionnelle
- Importance de tenir compte du contexte culturel et linguistique (environnement bilingue)



Trouble du développement du langage

Critères diagnostiques (DSM-5)

A

Difficultés persistantes d'acquisition et d'utilisation du langage

(oral, écrit, langue des signes ou autres)

- Vocabulaire réduit (lexique)
- Structure de phrase limitée (morphosyntaxe)
- Altérations du discours (capacité à utiliser le lexique et la syntaxe pour décrire ou pour tenir une conversation)



B

Niveau de langage inférieur aux attentes pour l'âge

Cela entraîne des limitations fonctionnelles dans :

- la communication efficace
- la participation sociale
- les apprentissages scolaires



C

Début des symptômes

Les symptômes apparaissent durant la période développementale précoce



D

Critères d'exclusion

- Les difficultés ne sont pas dues à :
 - un trouble auditif ou sensoriel
 - un dysfonctionnement moteur
 - une autre affection médicale ou neurologique
 - une déficience intellectuelle ou un retard global du développement

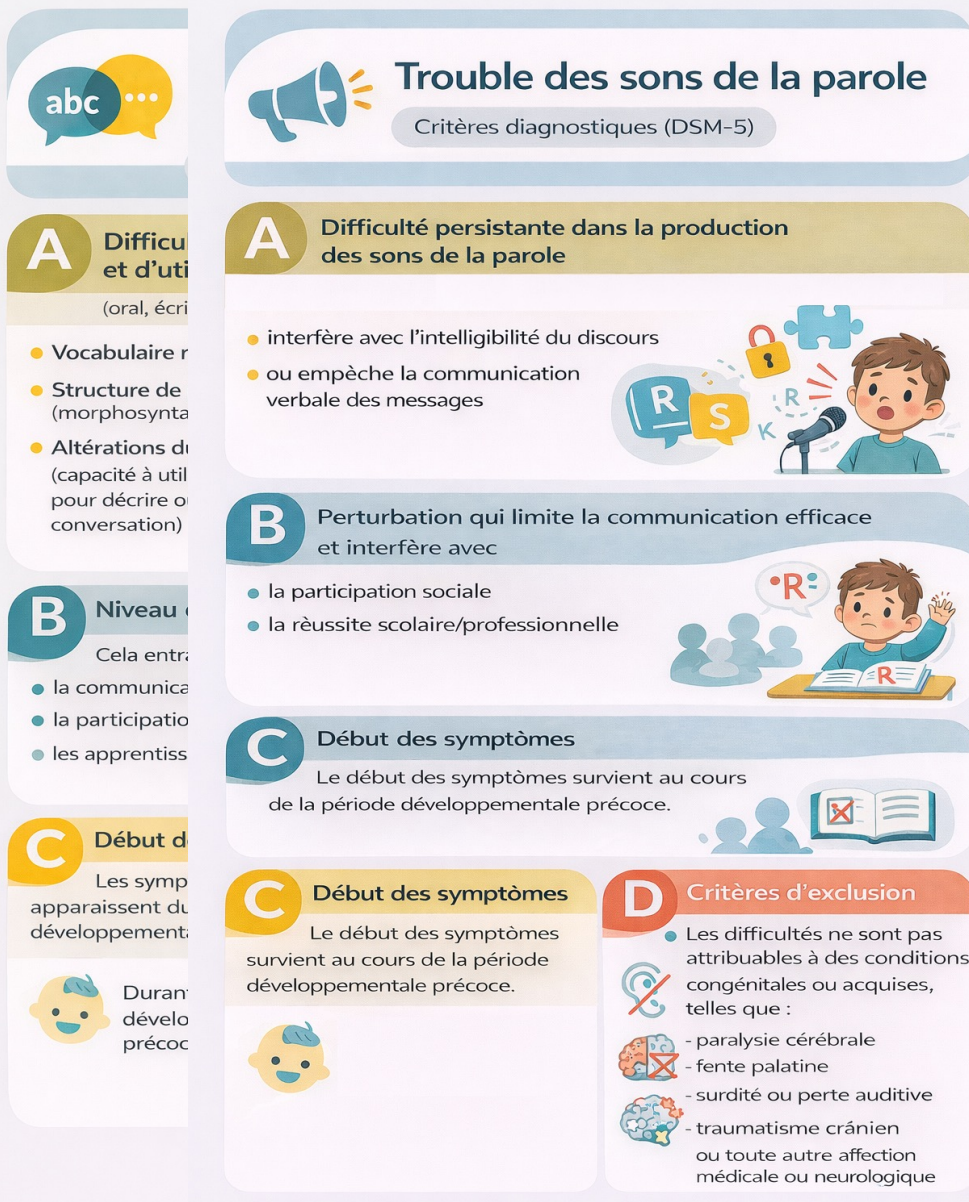
Exemple



C'est moi a gagné

La fille y donne l'os à le chien

Le garçon prend du bain y sale



Exemple



Chat > sa



Chien > Sien



Rouge > Louge



Train > Tain



Une brosse > bosse



Gateau > Tato



Camion > Tamion



Soleil > Soyeil



Souris > Chouris





A Difficulté de compréhension et d'utilisation du langage

(oral, écrit)

- Vocabulaire restreint
- Structure de la phrase (morphosyntaxe)
- Altérations de la compréhension (capacité à utiliser le langage pour décrire ou converser)

B Niveau de compréhension

Cela entraîne :

- la communication
- la participation sociale
- les apprentissages

C Début des symptômes

Les symptômes apparaissent au cours du développement



Durant le développement précoce



Trouble de la fluidité verbale

Critères

A Difficulté de production des sons de la parole

- interfère avec l'intelligence
- ou empêche la compréhension verbale des messages

B Perturbation de la participation sociale et interfère avec la réussite scolaire

- la participation sociale
- la réussite scolaire/ universitaire

C Début des symptômes

Le début des symptômes survient au cours de la période de développement précoce

C Début des symptômes

Le début des symptômes survient au cours de la période de développement précoce



Trouble de la fluidité verbale (bégaiement)

Critères diagnostiques (DSM-5)

A Perturbations de la fluidité normale et du rythme de la parole, inappropriées pour l'âge et les compétences langagières de la personne, persistantes dans le temps, et caractérisées par la présence fréquente et marquée d'un (ou plusieurs) des éléments suivants :

- Répétitions de sons ou de syllabes
- Prolongations de sons (consonnes ou voyelles)
- Mots interrompus (pauses à l'intérieur d'un mot)
- Blocages audibles ou silencieux (pauses remplies ou non)
- Périphrases (substitution de mots pour éviter ceux difficiles)
- Production de mots avec une tension physique excessive



B Cette perturbation entraîne une anxiété liée à la parole ou des limitations dans :

- la communication efficace
- la participation sociale
- la réussite scolaire ou les performances professionnelles, isolément ou en combinaison



C Début des symptômes

Le début des symptômes survient durant la période de développement précoce.



D Critères d'exclusion :

- à un déficit moteur de la parole ou sensoriel
- à une dysfluidité liée à une atteinte neurologique (ex : AVC, tumeur, traumatisme)
- à une autre affection médicale et n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental



Trouble du spectre de l'autisme



- Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) est un trouble développemental qui, à la base, affecte la façon dont l'individu perçoit son environnement social et socialise avec les autres
- présents durant la période développementale précoce mais peuvent ne se manifester pleinement plus tard que lorsque les exigences sociales augmentent être masqués par des stratégies compensatoires acquises
- 2 Pôles de symptômes : dyade autistique
- **impact fonctionnel** : Altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel
- **Diagnostic différentiel** : Ces troubles ne sont pas mieux expliqués par une déficience intellectuelle même si les deux peuvent fréquemment coexister

Dyade autistique

Déficit de la communication & interactions sociales

- déficit de la réciprocité sociale et émotionnelle
- déficit des comportements de communication non verbaux
- déficit du développement, du maintien et de la compréhension des relations

Comportements et intérêt à caractère restreints/répétitifs

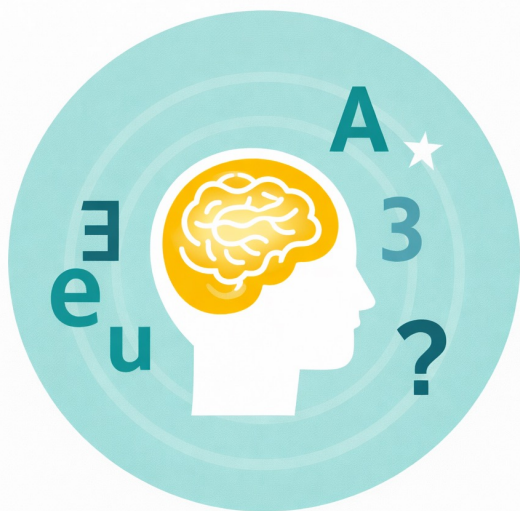
- Caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements, de l'utilisation des objets ou du langage
- intolérance aux changements, adhésion inflexible à des routines
- intérêt restreint ou fixe, anormaux dans leur orientation ou leur intensité
- hyper ou hyposensibilité aux stimuli sensoriels



Troubles du spectre de l'autisme (DSM-5)

- https://www.google.com/search?sca_esv=f903eaccdb3030a6&rlz=1C5CHFA_enBE932BE932&sxsrf=ANbL-n6wmdT8vH4TXjMxuqY1zBd93b7qUA:1776552776076&udm=7&fbs=ADc_I-bpk8W4E-qsVlOvbGJcDwpnAZSMear974weD6LplNmZUWw09uUlnNy1T6WmunrJd7J1iRONwwnkVHIJwSUsIvfpHhWIII4zICC-gg_zgzgtfC8a5653CUJRJAImIk4pa9ua6xrKJjqZ30St0tSGVVReRAc2PjiBRAqXqdbzxXlvOECmeLTqoJ8b7jLbE0enptlg-9j2&q=vid%C3%A9o+autisme&sa=X&ved=2ahUKEwia7ZHpvviTAxXx9QIHHeagNBkQtKgLegQIEBAB&biw=1403&bih=754&dpr=2#fpstate=ive&vld=cid:6259bd4b,vid:ualrdwHs2eY,st:0

Troubles spécifiques des apprentissages



Présentation détaillée dans l'ouvrage de Barlow (pg 521)

- Difficulté persistante dans certains domaines d'apprentissages scolaires
- Les compétences nettement au-dessous du niveau escompté pour l'âge chronologique du sujet
- Débutent au cours de la scolarité mais peuvent se réléver progressivement à mesure que les exigences scolaires augmentent
- **impact fonctionnel** : interfère de manière significative avec les performances scolaires, universitaires ou professionnelles, ou avec les activités de la vie courante
- **Diagnostic différentiel** : Ces troubles ne sont pas mieux expliqués par
 - une déficience intellectuelle > **troubles spécifiques !!**
 - des troubles non corrigés de l'acuité visuelle ou auditive,
 - autres troubles neurologiques ou mentaux,
 - Précarité psychosociale,
 - un manque de maîtrise de la langue de l'enseignement
 - un enseignement pédagogique inadéquat.

Symptômes



Langage écrit

- Lecture des mots inexacte ou lente et réalisée péniblement (ex. lenteur, erreurs ou hésitation en lecture de mots, devine souvent des mots, a des difficultés de déchiffrage).
- Difficultés à comprendre le sens de ce qui est lu (ex. peut lire un texte correctement mais ne pas comprendre l'ordre, les relations, la signification plus profonde de ce qui est lu).
- Difficultés à épeler (ex. peut ajouter, oublier ou substituer des voyelles ou des consonnes).
- Difficultés d'expression écrite (ex. erreurs grammaticales ou de ponctuation au sein des phrases; les paragraphes mal construits ; manque de clarté).



Mathématiques

- Difficultés à maîtriser le sens des nombres, les données chiffrées ou le calcul
 - > compréhension limitée des nombres, de leur ordre de grandeur et de leurs relations
 - > compte sur ses doigts pour additionner des nombres à un seul chiffre
 - > se perd au milieu des calculs arithmétiques et peut être amené à changer de méthode
- Difficultés avec le raisonnement mathématique
 - > difficultés à appliquer des concepts, des données ou des méthodes pour résoudre les problèmes

Troubles moteurs



- Les troubles moteurs incluent des difficultés dans l'acquisition, l'exécution et le contrôle des mouvements, qui ne sont pas expliquées par une condition neurologique connue.
- Présent durant la période développementale précoce
- Inclus
 - le trouble développemental de la coordination
 - Le trouble des mouvements stéréotypés
 - Le troubles des Tics (notamment Gilles de la Tourette)
- **Impact fonctionnel** sur la vie sociale, scolaire et professionnelle

Trouble développemental de la coordination (TDC)

(DSM-5 – Troubles moteurs)



A Déficit des habiletés motrices coordonnées

- Inférieures à celles attendues pour l'âge
- Malgré des opportunités d'apprentissage

Manifestations :

- **maladresse** (se cogne, laisse tomber)
- **lenteur et imprécision dans les gestes**
(attraper, écrire, vélo, sport et utilisation des outils)



B Impact significatif et persistant

- **Vie quotidienne** (s'habiller, manger...)
- **École** (écriture, activités pratiques)
- **Loisirs et jeux**

AUTONOMIE



C Début précoce

Début précoce :

- **Symptômes** présents durant l'enfance



D Critères d'exclusion

Non expliqué par :

-  **déficience intellectuelle**
-  **trouble visuel**
-  **atteinte neurologique**
(ex : paralysie cérébrale)

Un enfant avec TDC ne manque pas d'effort, mais rencontre une difficulté développementale dans la coordination motrice.

Trouble des mouvements stéréotypés

(Stereotypic Movement Disorder - DSM-5)



A Comportement moteur répétitif

- Comportements moteurs répétitifs, apparemment impulsés et sans but:

Exemples :

- battements ou secousses des mains
- balancement du corps
- coups de tête
- auto-morsures
- se frapper le corps



 **Peut entraîner** des blessures auto-infligées

B Retentissement fonctionnel

- Interfère avec :
- les activités sociales
- les apprentissages
- Loisirs/jeu

 **Peut entraîner** des blessures auto-infligées



D Critères d'exclusion

Non attribuable :

-  à une substance
-  à une affection neurologique

Non mieux expliqué par :

-  un autre trouble neurodéveloppemental
-  ou un trouble mental (ex : TOC, trichotillomanie)

C Développement

- Début durant la période développementale précoce



E Spécifications

- Avec ou sans
- comportement auto-agressif
- Peut être associé à :
- condition médicale ou génétique
- trouble neurodéveloppemental (ex : déficience intellectuelle, TSA)

F Sévérité



Léger : contrôlable par distraction

Modéré : nécessite aménagements / interventions

Sévère : nécessite surveillance et protection continues

Troubles des Tics

(DSM-5)

Syndrome de Gilles de la Tourette

Présence de multiples tics moteurs
Présence d'au moins un tic vocal
(pas nécessairement en même temps)



Trouble de tics moteur OU vocal persistant



Présence de tics moteurs **OU** vocaux
(mais pas les deux)
! N'a jamais rempli les critères de la Tourette

Temporalité

Fluctuent dans le temps
(vont et viennent)
Présents depuis plus d'1
an Début : avant 18 ans

Critères exclusion

Non attribuable :
- une substance
- à une autre
condition médicale

DÉFINITION DU TIC

- Mouvement moteur (tic moteur) ou vocalisation (tic vocal):
 - soudaine
 - rapide
 - récurrente
 - non rythmique

Exemples :

- clignements des yeux
- mouvements de la tête
- raclements de gorge
- vocalisations

Lorsque les tics sont présents depuis moins d'un an on parle de Trouble de tics provisoire, DSM 307.21 (F95.0))

